

NOTULEN

HARI / TANGGAL : SABTU / 24 MEI 2025
PUKUL : 09.00 – SELESAI
JENIS MEETING : RAPAT EVALUASI SOTK RUMAH SAKIT
TEMPAT : LOKASI DINAS MASING – MASING

Berikut hasil notulen :

No	Penjelasan
1	Pokok Bahasan : Satuan Pengawas Internal
	Masalah : Kedudukan SPI dan Direktur Rumah Sakit
	Pembahasan : - Struktur SOTK sekarang, posisi SPI ada di bawah direktur dengan garis bersifat instruksi. - Fungsi SPI adalah membantu direktur mengawasi operasional rumah sakit - SPI menyampaikan temuan-temuan di lapangan kepada direktur untuk kemudian ditindaklanjut ke kbid terkait
	Tindak Lanjut - SPI berada di kedudukan yang sama dengan Direktur Rumah Sakit dengan garis koordinasi - SPI bertugas untuk membantu direktur melakukan evaluasi, pengawasan dan supervisi seluruh kegiatan Rumah Sakit - SPI berkoordinasi langsung dengan PT Disa Prima Medika - SPI bersifat independent - Perbaiki SOTK untuk posisi SPI dan garis bersfiat koordinasi
2	Pokok Bahasan : Kbid Keperawatan
	Masalah : - PHS: Tugas Kbid Keperawatan masih tumpang tindih dengan Pelayanan Medis - PHM: Tugas Kbid Keperawatan masih tumpang tindih dengan Komite Keperawatan sehingga komite keperawatan tidak aktif. Sedangkan untuk Kbid Yanmed hanya sesekali membantu Kbid Keperawatan dalam area Rawat Jalan - RSDH: Tidak ada Kbid Keperawatan tetapi seluruh tugas keperawatan di handle oleh Komite Keperawatan - Apabila Kbid Keperawatan dijadikan 1 dengan Kbid Pelayanan Medis, bagaimana dengan SDM yang mengisi apabila berasal dari latar belakang non perawat?
	Tindak Lanjut - Kbid Keperawatan dihilangkan - Mengembalikan kembali fungsi Komite Keperawatan - Komite Keperawatan dibagi sub lagi, ada yang fokus ke mutu SDM perawat dan ada yang administratif - Tunjangan jabatan untuk Komite Keperawatan akan ditinjau lebih lanjut
3	Pokok Bahasan : Kepala Bidang Penunjang
	Masalah : - Asuransi center lebih berkoordinasi dengan unit rekam medis dan mencakup seluruh kegiatan rumah sakit - Apakah dijadikan 1 dengan pelayanan medis?

	3. Asuransi center memiliki cakupan yang luas, tidak hanya pelayanan medis tetapi juga penunjang seperti kelengkapan hasil pemeriksaan dll
	Tindak Lanjut 1. Asuransi center berada di bawah direktur langsung
4	Pokok Bahasan : Kepala Bagian Umum
	Masalah : 1. Perubahan SOTK dan Unit dari Kepala Bagian Umum 2. Selama ini masing-masing divisi memiliki kepala / karu tersendiri, baik IPSRS, IT, Driver, Security, CS 3. Saran humas marketing dikeluarkan dari bawah naungan kabag umum dan berada langsung di bawah direktur 4. SDM Diklat terpusat dari PT sehingga SDM RS bersifat pelaksana saja, bisa langsung di bawah direktur (real nya akan dikoordinir oleh Manajer HRD PT)
	Tindak Lanjut 1. SDM dan diklat setuju tidak masuk dalam ranah kepala bagian umum dan lebih banyak di handle oleh PT dan akan di tunjang dengan sistem SDM (HRIS) untuk memudahkan sehingga hanya memerlukan 1 SDM tiap Rumah Sakit 2. Humas dan marketing setuju akan langsung berkoordinasi dengan direktur 3. Driver, security, tenant & parkir, pemulasaran jenazah dan cs akan dijadikan satu unit dibawah 1 komando yaitu Pak Rizal untuk langsung berkoordinasi dengan Kepala Bagian Umum
5	Pokok Bahasan : PKRS dan Desain
	Masalah : 1. SDM Desain maupun multimedia tidak dapat dijadikan PKRS
	Tindak Lanjut 1. Desain akan di pusatkan di PT Disa Prima Medika untuk kedua Rumah Sakit 2. PKRS akan berfokus pada Promosi Kesehatan internal dalam rumah sakit bukan desain 3. Dalam pemilihan SDM yang mengisi PKRS maupun Humas Marketing sebaiknya yang juga memiliki skill desain agar tidak terlalu bergantung pada desain 4. Akan didiskusikan lebih lanjut

Pemimpin Rapat



(dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE)

Malang, 24 Mei 2025

Notulis

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

(Adinda Lestari Putri, S.KM)

LAMPIRAN SOTK

